

ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ [CO]

Γενικά: Σπάνιες πλέον σήμερα οι δηλητηριάσεις με μονοξείδιο του άνθρακα, εμφανίζονται κυρίως σε πυρκαγιές και τους χειμερινούς μήνες στο οικιακό περιβάλλον από κακή χρήση, εγκατάσταση και λειτουργία διαφόρων θερμαντικών μέσων (ξύλοσομπες, μαγκάλια, κ.λπ.).

Κλινική εικόνα: Σταθερό εύρημα αποτελεί η **γλυκοζουρία** κεντρικής μάλλον αιτιολογίας. Παρατηρούνται επίσης δύσπνοια, ταχύπνοια, ταχυαρρυθμίες, υπόταση, κεφαλαλγία, εμβοές, κόπωση, ναυτία, έμετος, διάρροια, μυδρίαση, φλογοειδείς αιμορραγίες του κερατοειδούς, υπερπυρεξία, διαταραχές μνήμης και ψυχισμού και συμπτώματα που προσομοιάζουν με ΑΕΕ (συχνά εκλύεται Babinski) ή με νόσο του Parkinson ή δηλητηρίαση με οινόπνευμα.

Τα συμπτώματα της οξείας δηλητηρίασης από CO είναι απότοκα της ανοξίας των ιστών, του ΚΝΣ και του μυοκαρδίου. Η τοξίκωση από CO δεν προκαλεί κυάνωση! Αντιθέτως, το θύμα (συνήθως ο νεκρός) εμφανίζει ρόδινη (κερασόχροη) απόχρωση στο δέρμα, στα νύχια και τους βλεννογόνους, αναλόγως της συγκέντρωσης της Ανθρακυλαιμοσφαιρίνης (HbCO) στο αίμα.

Η παλμική οξυμετρία (SpO₂) παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες και κρίνεται αναξιόπιστη καθώς η απορρόφηση φωτός από την HbCO είναι παρόμοια με αυτή της οξυαιμοσφαιρίνης.

Προϊούσας της τοξικότητας του CO, εμφανίζεται έκπτωση επιπέδου συνειδήσεως (εστιακή νευρολογική σημειολογία ή/και γνωσιακές διαταραχές), σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, οξύ πνευμονικό οίδημα, ισχαιμία μυοκαρδίου, απειλητικές αρρυθμίες, μεταβολική οξέωση, φλοιώδης τύφλωση, εγκεφαλικό οίδημα, σύγχυση, λήθαργος, κώμα και τελικά θάνατος.

Τα παιδιά και γενικότερα άτομα με αυξημένο μεταβολισμό, όπως ασθενείς με αναιμία, με υπερθυρεοειδισμό, με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, οι έγκυες, καθώς και οι χρόνιοι αλκοολικοί εμφανίζουν ιδιαίτερη ευαισθησία στην έκθεση στο CO.



Θεραπευτική παρέμβαση

1. Μεριμνούμε ώστε ο ασθενής να βρίσκεται σε ηρεμία και ακινησία, για τον περιορισμό της κατανάλωσης οξυγόνου, ενώ τον προστατεύουμε και από την απώλεια θερμότητας.
2. Μεριμνούμε για τη διατήρηση της ΑΠ και της θερμοκρασίας σε φυσιολογικά επίπεδα. Σε περίπτωση υπερθερμίας, τοποθετούνται ψυχρά επιθέματα (μασχάλες, βουβώνες, κ.λπ.).
3. Καθαρίζεται (αναρρόφηση) η στοματορρινική κοιλότητα από τυχόν υπάρχοντα εμέσματα.
4. Χορηγούμε άμεσα, με μάσκα μη επανεισπνοής, οξυγόνο (O₂) 100%, συνεχώς, επί 4 ώρες.
5. Τοποθετείται 3way φλεβική γραμμή, με 1000 ml NaCl 0,9% και 500 ml D5W, παράλληλα με 1-3 amp. Lasix· για ενυδάτωση, για αποφυγή μη καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος και για αποφυγή οξείας νεφρικής βλάβης λόγω ραβδομύλωσης (δευτερογενείς επιπλοκές).
6. Προς αντιμετώπιση του εγκεφαλικού οιδήματος χορηγείται 1 amp. Dexamethasone 8 mg (με αμφιλεγόμενη χρησιμότητα). Εναλλακτικά, χορηγούνται 200 ml Μαννιτόλη 20%.
7. Για τον έλεγχο των σπασμών, χορηγούμε 1 amp. Stedon 10 mg, εντός 100 ml N/S (iv).
8. Διακομίζουμε στο νοσοκομείο κι εφόσον είναι εφικτό σε κέντρο με θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου (μίγμα 95% O₂ και 5% CO₂, υπό πίεση στις 2,5-3 atm, για 90-120 λεπτά), ειδικά τους ασθενείς με συμπτώματα καρδιακής ισχαιμίας, νευρολογική σημειολογία ή εγκύους.
9. Ήπιες διαταραχές του ΚΝΣ πιθανώς να επιμείνουν για μήνες μετά την αρχική θεραπεία και στις περιπτώσεις αυτές έχει προταθεί η χρήση Ν-Ακετυλοκυστεΐνης (αντιοξειδωτικό).